Textes de présentation stratégique d'IVIA — Un message par connecteur

> **Mode d'emploi :** Chaque section est un texte prêt à l'emploi, calibré sur le langage, les priorités et les critères formels de l'interlocuteur visé. Copier-coller directement dans un courriel, un formulaire, ou une prise de contact LinkedIn. Les crochets `[…]` indiquent les variables à compléter selon le contexte d'envoi.

1. RSN Québec — Réseau santé numérique (FRQ)

Interlocuteur : Isabelle Belley-Ferris (Directrice Stratégie et Opérations) ou Sara Ahmed (Directrice scientifique)[^1]
Contact : RSNQuebec@rimuhc.ca[^2]
Registre : Académique-partenarial, langage recherche, appui aux axes Axe 1 (gouvernance informationnelle) et Axe 3 (interventions numériques)[^3]

Objet : Demande d'affiliation au RSN — Plateforme IVIA, données probantes et intervention numérique en santé préventive au Québec

Madame Belley-Ferris / Madame Ahmed,

Le Réseau santé numérique du FRQ–Santé s'est doté d'une mission que nous partageons pleinement : propulser le potentiel du numérique pour améliorer la santé, en privilégiant la confiance, l'équité et l'engagement citoyen. C'est dans cet esprit que nous vous soumettons cette demande d'affiliation à titre de membre partenaire.[^3]

IVIA (*In Vivo In Actu*) est une plateforme québécoise de santé préventive conçue pour réduire l'errance des usagers dans le système de soins, par un moteur d'orientation prudent (MERLIN) et un espace d'accompagnement empathique non-clinique (MÉSANGE). L'architecture d'IVIA repose sur trois principes fondateurs qui résonnent directement avec les axes du RSN :

1. **Gouvernance souveraine des données** — Hébergement exclusif sur infrastructure canadienne (OVH Canada), effacement biométrique vocal à J+30, aucune agrégation vers des tiers. Ce positionnement s'inscrit dans votre Axe 1 (Plateformes numériques et gouvernance informationnelle) et dans les principes *Numérique de confiance* et *Science ouverte* du RSN.[^3]
2. **Intervention numérique fondée sur des données probantes** — IVIA développe un indicateur original, l'*Indicateur de temporalité décalée*, qui mesure systématiquement l'écart entre la date d'écriture d'un souvenir et la date de l'événement évoqué dans les journaux clients. Cet outil, protégé par prior art documenté (GitHub, mai 2026), n'a pas d'équivalent recensé dans les plateformes québécoises ou francophones. Il constitue un différenciateur scientifique que nous souhaitons soumettre à la communauté de

recherche dans le cadre d'un protocole de validation collaboratif — idéalement en partenariat avec un chercheur régulier du RSN.

3. **Transformation numérique du système de soins de première ligne** — MERLIN est conçu pour améliorer l'articulation entre la compréhension du besoin, la sécurité et l'orientation, en réduisant les délais et l'errance dans les services de première ligne. Ce positionnement s'inscrit dans votre Axe 4 (Transformation numérique) et dans la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 du MSSS.[4][5]

IVIA répond à la définition de *membre partenaire* du RSN : une organisation sans statut académique propre, mais dotée d'une expertise pratique et d'un savoir expérientiel en lien direct avec les activités du réseau. Nous souhaiterions contribuer activement aux activités du RSN, notamment en apportant des données réelles d'utilisation issues du pilote IVIA et en participant aux événements de mobilisation des connaissances.[^3]

Nous serions honorés d'échanger avec vous sur les modalités d'affiliation et sur les axes de collaboration scientifique les plus pertinents.

Cordialement,

David Phaneuf
Fondateur, IVIA (*In Vivo In Actu*)
ivia.quebec

2. MEDTEQ+ — Programme AVISÉ

Interlocuteur : Équipe AVISÉ[^6]
Contact : avise@medteq.ca[^6]
Registre : Entrepreneurial-technique, langage évaluation de technologies, TRL, valeur globale, besoins prioritaires du RSSS[^6]

Objet : Pré-dépôt AVISÉ — Technologie de santé numérique IA pour l'accès aux soins de première ligne et la prévention

Madame, Monsieur,

Je vous contacte dans le cadre du Programme AVISÉ de MEDTEQ+ afin de vous soumettre un projet de validation de la plateforme **IVIA**, une technologie québécoise de santé numérique utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux soins de première ligne et réduire l'errance des usagers dans le système RSSS.

La problématique adressée

Les listes d'attente en santé mentale et en soins de première ligne, l'errance des usagers entre les services, et la surcharge des urgences constituent des défis documentés du système québécois. IVIA répond directement aux thématiques prioritaires du programme AVISÉ :[^6]

- **Accès aux soins primaires (première ligne)** — MERLIN, le moteur d'orientation d'IVIA, guide prudemment les usagers vers le bon service, au bon moment, selon une grille structurée de besoins.

- **Parcours du patient de l'admission à la fin des suivis** — MÉSANGE, l'interface d'accompagnement d'IVIA, assure une continuité empathique non-clinique entre les consultations formelles.

La technologie et son niveau de maturité

IVIA est une plateforme FastAPI (Python) / React hébergée sur infrastructure canadienne (OVH Canada), intégrant des modèles de langage (GPT-4.1, Claude) pour l'analyse de sessions audio en temps réel. Le niveau de maturité technologique se situe actuellement entre **TRL 7 et TRL 8** — la technologie est démontrée, le déploiement pilote en milieu réel d'utilisation est planifié pour [date pilote].

IVIA possède les droits complets sur sa propriété intellectuelle, notamment sur l'*Indicateur de temporalité décalée IVIA*, un outil d'analyse clinique original protégé par prior art documenté et prévu sous licence CC BY-NC-SA 4.0.

Ce que nous demandons à AVISÉ

Nous souhaitons financer une étude d'évaluation en milieu réel d'utilisation (18 mois, dont 12 mois d'évaluation) visant à démontrer la valeur globale d'IVIA selon les dimensions : économique, populationnelle, clinique et organisationnelle. Le projet serait conduit en partenariat avec le RÉIS dans [un milieu privé / un milieu privé et un milieu public selon disponibilité], en conformité avec le Guide AVISÉ.[^6]

L'entreprise IVIA (SPA MERLIN inc. / OBNL IVIA) est légalement constituée au Québec, dirigée par un fondateur à temps plein, et détient les droits sur sa propriété intellectuelle.[^6]

Seriez-vous disponibles pour un appel de qualification pré-dépôt afin de confirmer l'admissibilité du projet et identifier l'équipe RÉIS la mieux adaptée ?

Cordialement,

David Phaneuf
Fondateur, IVIA (*In Vivo In Actu*)
avise@medteq.ca (en réponse à cet envoi)

3. Bureau de l'innovation en santé — MSSS

Interlocuteur : Équipe d'accompagnement du BI[7][8]
Contact : 2021, avenue Union, 8e étage, Montréal (Québec) H3A 2S9[^8]
Registre : Institutionnel-public, langage système de santé, adoption, déploiement dans le RSSS, compétitivité des entreprises québécoises[^8]

Objet : Demande de service — Innovation en santé numérique et bien-être préventif, plateforme IVIA

Madame, Monsieur,

Le Bureau de l'innovation du MSSS a pour mandat d'accélérer l'adoption des innovations pertinentes dans le réseau de la santé et des services sociaux, et de contribuer à la

compétitivité des entreprises québécoises en sciences de la vie. C'est précisément le parcours que nous cherchons à entreprendre avec la plateforme IVIA.[^8]

Qui sommes-nous

IVIA (*In Vivo In Actu*) est une entreprise québécoise de santé préventive et numérique fondée à Montréal. Notre mission est de réduire l'errance dans le système de soins et de soutenir le bien-être des Québécois avant qu'ils n'atteignent le seuil clinique. IVIA s'inscrit directement dans la **Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035** du MSSS et dans son Plan d'action gouvernemental 2026-2031 : nous sommes un outil de prévention, de première ligne et d'orientation prudente.[^5]

Ce que IVIA apporte au RSSS

- **MERLIN** : moteur d'orientation qui réduit l'errance des usagers en les guidant vers le bon service, au bon moment, sans poser de diagnostic[^4]
- **MÉSANGE** : interface d'accompagnement empathique non-clinique, positionnée hors-psychothérapie conformément à la Loi 21, qui soutient la prévention et l'autonomie émotionnelle
- **Gouvernance souveraine** : toutes les données restent au Québec, hébergées au Canada, sous contrôle de l'usager, en conformité avec la Loi 5 (LRSSS) et la Loi 25[^9]

Ce que nous demandons au Bureau de l'innovation

Nous souhaitons initier le **Parcours client BI** (Étape 1 : demande de service) afin d'identifier le Hub RUISSS le plus adapté à un pilote de validation dans le RSSS, et explorer une intégration potentielle dans les structures de soins de première ligne ou les milieux communautaires.[10] [7]

La plateforme est en phase de pré-commercialisation (TRL 7-8). Nous disposons d'une architecture technique validée et d'un dossier de propriété intellectuelle protégé. Nous cherchons un partenaire institutionnel québécois pour les 18 prochains mois.

Nous vous invitons à nous contacter pour initier la demande formelle d'accompagnement.

Cordialement,

David Phaneuf
Fondateur, IVIA (*In Vivo In Actu*)
ivia.quebec

4. Services aux Autochtones Canada — Fonds d'équité en santé autochtone (Initiatives ciblées)

Interlocuteur : Équipe du programme, Initiatives ciblées[^11]
Contact : fesa-ihef@sac-isc.gc.ca[^11]
Registre : Fédéral, langage équité, autodétermination, savoirs autochtones, partenariat communautaire, gouvernance des données[12][11]

Objet : Proposition d'initiative ciblée — Plateforme IVIA pour l'équité en santé et le mieux-être des communautés autochtones au Québec

Madame, Monsieur,

Le Fonds d'équité en santé autochtone finance des projets novateurs, dirigés par les Autochtones, visant l'amélioration d'un aspect de la santé des peuples autochtones. La plateforme **IVIA** a été conçue avec les valeurs d'autodétermination, de gouvernance souveraine des données et d'intégration des savoirs ancestraux au cœur de son architecture — des principes en alignement direct avec vos critères d'évaluation.[12][11]

Le problème que nous adressons

Les Premières Nations et les Inuit au Québec font face à des inégalités documentées en matière d'accès aux services de santé mentale, de bien-être et de soins culturellement adaptés. L'INSPQ a documenté que la santé autochtone doit être abordée selon une conception holistique incluant le territoire, la culture, la langue et les relations sociales. IVIA est précisément conçu pour cette approche : ce n'est pas un outil clinique occidental projeté sur des communautés, mais une plateforme d'écoute et d'orientation qui intègre les savoirs ancestraux, le rapport au territoire et la connexion intergénérationnelle comme leviers du mieux-être.[^13]

Notre approche

IVIA intègre dans son modèle analytique (MERLIN) les principes de l'INSPQ en recherche autochtone :[^12]

- **Autodétermination et gouvernance des données** : les données ne quittent jamais les infrastructures canadiennes, l'usager en est le souverain
- **Construction de relations** : MÉSANGE est une interface d'accompagnement relationnel, pas un formulaire clinique
- **Respect de la culture et des valeurs** : l'axe territoire est l'axe primaire d'IVIA — la personne est d'abord ancrée dans un lieu avant d'être ancrée dans un corps
- **Respect du consentement** : la politique de gouvernance IVIA prévoit un effacement biométrique vocal automatique à J+30 et aucune agrégation sans consentement explicite

Ce que nous proposons

Nous sollicitons un financement d'**initiative ciblée** (maximum 500 000 $, durée 2 à 3 ans) pour co-développer, avec une ou plusieurs communautés partenaires de Premières Nations au Québec, une version culturellement adaptée d'IVIA intégrant des protocoles d'écoute issus des savoirs autochtones. Ce projet serait co-dirigé avec l'organisation communautaire partenaire, en respect total des principes PCAP® (Propriété, Contrôle, Accès, Possession). [^12]

Nous sommes ouverts à un dialogue préliminaire pour identifier la communauté partenaire la plus adaptée et vérifier l'admissibilité de notre proposition.

Cordialement,

David Phaneuf
Fondateur, IVIA (*In Vivo In Actu*)
ivia.quebec

5. FRQ-Santé + IRSC — Programme ÉTAPE

Interlocuteur : Comité d'évaluation des Fonds de recherche du Québec (FRQ) / IRSC[^14]
Contact : Via le portail FRQ (prochaine édition à surveiller — résultats mai 2026 pour le dernier concours)[^14]
Registre : Scientifique-programmatique, langage résultats de santé populationnelle, équité, systèmes de santé publique, preuves[^14]

Titre du projet proposé : *IVIA — Une infrastructure de données préventives et d'orientation souveraine pour réduire les inégalités d'accès aux soins de première ligne au Québec*

Résumé de la proposition

Les inégalités d'accès aux soins de première ligne touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables au Québec : personnes en situation de précarité, communautés autochtones, populations éloignées et personnes en difficulté de santé mentale sous le seuil clinique. Ces personnes errent entre les services sans trouver le point d'entrée adapté à leur situation.

La plateforme IVIA (*In Vivo In Actu*) est une réponse québécoise à cette lacune. Elle combine un moteur d'orientation prudent (MERLIN), un espace d'accompagnement non-clinique (MÉSANGE) et un outil d'analyse innovant — l'*Indicateur de temporalité décalée* — qui mesure l'écart entre le moment d'écriture d'un souvenir et la date de l'événement évoqué. Cet indicateur ouvre une perspective de recherche sur les processus de rumination, de régulation émotionnelle différée et de vulnérabilité psychosociale, sans jamais poser de diagnostic.[^4]

Alignement avec les objectifs du programme ÉTAPE

Le programme ÉTAPE vise à favoriser la résilience et l'équité au sein des systèmes de santé publique, en soutenant le rôle du secteur communautaire. IVIA s'inscrit dans cet objectif à trois niveaux :[^14]

1. **Équité d'accès** : en rendant l'orientation dans le système de soins accessible à des populations qui n'ont pas les ressources pour naviguer seules
2. **Résilience systémique** : en délestant les services de première ligne d'une partie des demandes d'orientation non urgentes, non cliniques
3. **Secteur communautaire** : en opérant dans la zone de l'accompagnement non réglementé, complémentaire aux professionnels du RSSS

Équipe et partenariats

Ce projet serait conduit en partenariat avec [chercheur·e affilié·e RSN / université québécoise], [organisation communautaire partenaire], et s'appuierait sur les infrastructures de données de l'IVIA déployées en milieu réel sur une période de 36 mois.

Budget estimé : 600 000 $ sur 3 ans (conformément au plafond du programme ÉTAPE)[^14]

6. Mitacs — Partenariat entreprise-université

Interlocuteur : Conseiller Mitacs, bureau de Montréal[^15]
Contact : Via le portail Mitacs (demandes continues)
Registre : Innovation collaborative, talent R&D, stage rémunéré, transfert technologique PME[^15]

Objet : Partenariat Mitacs — Stagiaire R&D en santé numérique et analyse comportementale pour IVIA

Madame, Monsieur,

Mitacs connecte les entreprises innovantes québécoises avec la relève universitaire pour accélérer leurs projets de R&D. C'est exactement ce dont IVIA a besoin pour franchir l'étape de la validation scientifique de ses algorithmes.[^15]

Le contexte

IVIA est une plateforme québécoise de santé numérique préventive en phase de déploiement pilote. Son moteur analytique MERLIN génère, lors de chaque session d'accompagnement, un ensemble de signaux comportementaux et linguistiques qui nécessitent une validation scientifique rigoureuse. En particulier, l'*Indicateur de temporalité décalée IVIA* — qui mesure l'écart entre la date d'écriture d'un souvenir et la date de l'événement évoqué — représente une piste de recherche originale en psychologie cognitive et en santé numérique.

Le projet de stage

Nous cherchons un·e stagiaire Mitacs (niveau maîtrise ou doctorat) issu·e d'une université québécoise pour un mandat de 4 à 6 mois, avec possibilité de prolongation, portant sur :

- L'analyse statistique des données de temporalité décalée issues des journaux clients IVIA
- La validation de l'indicateur par comparaison avec des outils psychométriques reconnus (PHQ-9, GAD-7, etc.)
- La rédaction d'un protocole de recherche éthiquement encadré, en vue d'une soumission dans une revue de santé numérique

Ce que nous offrons

- Accès à des données réelles, anonymisées et gouvernées selon la Loi 5 (LRSSS) et la Loi 25
- Infrastructure technique documentée et hébergée au Canada
- Encadrement par le fondateur de la plateforme, avec co-direction universitaire à identifier parmi les membres du RSN Québec[^16]
- Contribution à la co-publication des résultats

Seriez-vous disponibles pour un appel de 30 minutes afin d'explorer la faisabilité de ce partenariat ?

Cordialement,

David Phaneuf
Fondateur, IVIA (*In Vivo In Actu*)
ivia.quebec

Tableau de synthèse — Registre et positionnement par contact

Contact	Axe principal d'IVIA mis en avant	Langage clé	Format d'approche
RSN Québec	Gouvernance des données + innovation scientifique (Indicateur IVIA)	Axes thématiques RSN, membre partenaire, apport interdisciplinaire[^3]	Courriel formel, demande d'affiliation
MEDTEQ+ AVISÉ	Accès aux soins de première ligne, IA, TRL 7-8	Valeur globale, milieu réel, besoins prioritaires RSSS, non remboursable[^6]	Courriel pré-dépôt + appel de qualification
Bureau innovation MSSS	Prévention, déploiement dans le RSSS, Loi 5	Adoption, compétitivité, Parcours client BI, Hubs RUISSS[8][7]	Étape 1 BI (demande de service)
SAC — Fonds équité autochtone	Volet territorial, savoirs ancestraux, PCAP®	Autodétermination, gouvernance souveraine, approche holistique[12][11]	Proposition d'initiative ciblée
FRQ-IRSC ÉTAPE	Équité + résilience systémique + Indicateur de temporalité	Équité d'accès, secteur communautaire, données probantes[^14]	Dossier de demande de subvention d'équipe
Mitacs	Validation scientifique de l'Indicateur IVIA	Stage rémunéré, R&D, co-publication, transfert technologique[^15]	Demande de partenariat, appel préliminaire

References

1. Gouvernance – RSN - Réseau santé numérique - Sara Ahmed, PT, PhD · Directrice scientifique ; Philippe Després, PhD · Co-directeur ; Aude Motulsky...
2. Lancement du Réseau santé numérique du FRQ-Santé à L'Institut - ... (RSN); David Buckeridge, directeur du centre de recherche en santé numérique à L'Institut; et la...
3. [PDF] CHARTE - Réseau santé numérique - Le RSN fédère pour la première fois les forces vives de la recherche en santé numérique au Québec, u...
4. [Je construis MERLIN, un moteur d’orientation prudent dans le système de soin québécois.

MERLIN n’est pas un outil de diagnostic.
MERLIN n’a pas vocation à remplacer les médecins, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux ou institutions.
M...

...de permettre ensuite :

- une grille canonique des soins institutionnels
- un moteur d'orientation prudent
- une réduction de l'errance des usagers
- une meilleure articulation entre compréhension du besoin, sécurité, orientation et accompagnement] (https://www.perplexity.ai/search/bcc0fe9b-1927-41f9-9592-f62256d24c60) - 1. Vue d'ensemble du système québécois
  (vision opérationnelle pour MERLIN)

Le réseau québécoi...

5. Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 - En novembre 2024, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la mise en place d'une ...
6. Programme AVISÉ | MEDTEQ+ - Critères d'évaluation. Les étapes du processus d'évaluation sont définies dans le guide de l'appel. ...
7. MSSS - Bureau de l'innovation en santé et en services sociaux - Le Bureau de l'innovation (BI) vise à accélérer l'adoption des innovations et des nouvelles technolo...
8. À propos du Bureau de l'innovation en santé et en services sociaux - Le BI collabore avec divers partenaires de l'écosystème d'innovation en santé et en services sociaux...
9. [PDF] Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (Loi 5) - La Loi sur les renseignements de santé et de services · sociaux (LRSSS, ci-après « la Loi »), entrée...
10. Hubs d'innovation en santé et services sociaux - Les hubs d'innovation sont des espaces de collaboration et de services en innovation au sein du rése...
11. Fonds d'équité en santé autochtone - Initiatives ciblées - Ce financement est destiné aux projets axés sur un objectif particulier visant l'amélioration d'un a...
12. Principes autochtones de recherche : contribution à la ... - Des organisations et des communautés autochtones ont développé des principes de recherche pour sensi...
13. Santé des Autochtones | INSPQ - Le volet santé des Autochtones est dédié à l'amélioration de la santé et du mieux-être des Premières...
14. Appel de propositions - Fonds de recherche du Québec - FRQ - ... cihr-irsc.gc.ca. Date limite d'inscription : 17 septembre 2025. Date limite de présentation des ...
15. L'innovation en santé numérique a besoin de talents et d ... - Mitacs - Mitacs met en relation des talents et des partenaires au Québec pour accélérer la santé numérique, f...
16. Lancement du Réseau santé numérique du FRQ-Santé à L'Institut - Notre mission est de propulser le potentiel du numérique pour améliorer la santé. Plus de 180 cherch...